



Estratégias Imediatas

As estratégias imediatas são ações de cuidado em um percurso singular, no momento que se entende que há uma crise instalada no ecossistema de uma pessoa. O objetivo das respostas imediatas é a proteção da vida, a redução de danos e a restauração da hospitalidade do cuidado por meio de políticas, estratégias e intervenções que fortaleçam o vínculo, promovam a escuta qualificada e se empenhem em não reproduzir violências institucionais.

As ações imediatas em situações de crise têm como orientação uma compreensão ampliada do sofrimento mental, reconhecendo que a crise não é um evento exclusivamente individual, mas o resultado da interação entre fatores subjetivos, relacionais, sociais e institucionais. Nesse sentido, qualquer ação de cuidado deve enfrentar esse conjunto de relações, o “ecossistema biopolítico” interseccional de hostilidade, violência e coerção societal e institucional que incide de forma desproporcional sobre pessoas em sofrimento mental, fragilizando o laço social e ampliando riscos em situações de crise.

A abordagem inicial de qualquer situação de crise exige avaliação contínua e qualificada de vulnerabilidade. Essa avaliação deve considerar não apenas sinais clínicos e psíquicos, mas também fatores contextuais, como condições ambientais, relações interpessoais, experiências recentes de violência, coerção ou exclusão, ausência de suporte social e falhas institucionais. A crise é compreendida como um fenômeno relacional e situado, e não apenas como expressão de sintomas individuais.

As intervenções mediadoras constituem o eixo prioritário da resposta imediata e devem ser constantemente reavaliadas, ampliadas ou ajustadas conforme a evolução da situação. Diante da identificação de risco ou escalada de tensão, devem ser priorizadas intervenções mediadoras voltadas à continência e à desescalada da crise. Essas intervenções incluem estratégias de acolhimento, comunicação clara, escuta ativa, negociação, adaptação do ambiente e, quando indicado, a tranquilização medicamentosa de forma voluntária, por via oral ou parenteral. O uso de medicação deve ocorrer com consentimento, proporcionalidade e finalidade exclusivamente terapêutica, integrando um conjunto mais amplo de estratégias de cuidado.

Durante todo o processo de manejo das situações, deve haver reavaliação contínua das condições de risco, da resposta do usuário às intervenções e do grau de hospitalidade do cuidado ofertado. As estratégias mediadoras reduzem gradualmente medidas mais invasivas e devem ser usadas para destacar o protagonismo do usuário no cuidado.

Encerrada a fase aguda da crise, é obrigatória a realização de revisão pós-crise e pós-incidente. Essa revisão deve ocorrer de forma imediata e, posteriormente, de maneira estruturada, com participação multiprofissional, do usuário e, sempre que possível, de seu laço social. O objetivo dessa etapa é compreender os determinantes da crise, avaliar os impactos das intervenções realizadas, reparar eventuais danos, prevenir recorrências danosas e fortalecer vínculos, autonomia e confiança no cuidado.